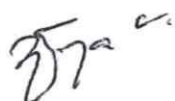


STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGAMBILAN DARAH KONVENSIONAL

NO DOKUMEN	:	UDDP-PDD-L2-003
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	13. Des 2022
TANGGAL REVIEW	:	13 Des 2024
STATUS DOKUMEN	:	☐ MASTER ☐ COPY NO :

Disusun oleh: Iftitah Uli Azmi, A.Md.Kes Petugas Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 05.12.2022
Diperiksa oleh : dr. Idah Wido Sari N Kasie. Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 07.12.2022
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M.Biomed Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 09.12.2022
Disahkan oleh: Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 12.12.2022

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PENGAMBILAN DARAH KONVENSIONAL		Halaman 1 dari 5 Nomor : UDDP-PDD-L2- 003 Versi : 001 Tgl. berlaku : 13 Des 2022 Tgl. kaji ulang : 13 Des 2024
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini sebagai petunjuk untuk menjamin pengambilan darah lengkap dari pendonor untuk memenuhi kebutuhan transfusi bagi penyembuhan penyakit atau pemeliharaan kesehatan sesuai standar.

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh seluruh staf pengambilan darah di UDDP PMI dalam melakukan pengambilan darah, mulai dari menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), melakukan persiapan peralatan dan bahan habis pakai, persiapan dokumentasi, identifikasi pendonor, desinfeksi lengan pendonor, pengambilan darah, perawatan luka tusuk jarum, dan monitoring pendonor pasca penyumbangan darah.

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

3. Persyaratan Sistem Kualitas

3.1 CPOB BPOM Butir 7.36

Donor hendaklah memastikan identitasnya (misal nama dan tanggal lahir) segera sebelum penusukan vena. Hendaklah juga dilakukan pemeriksaan untuk memastikan sistem pengambilan darah yang digunakan tidak rusak atau terkontaminasi dan sesuai dengan tujuan pengambilan. Kelembapan yang tidak sesuai atau perubahan warna menunjukkan kerusakan, sehingga pada kondisi tersebut hendaklah perangkat pengambilan darah dibuang. Hendaklah dilaksanakan investigasi untuk mengevaluasi permasalahan yang terjadi dan tindakan perbaikan hendaklah diambil.

3.2 CPOB BPOM Butir 7.37

Sistem pengambilan hendaklah dilakukan sesuai dengan instruksi pembuat. Prosedur desinfeksi lengan yang tepat dan higiene personil hendaklah tersedia dan dilakukan oleh petugas sebelum donasi darah dilaksanakan.

3.3 CPOB BPOM Butir 7.38

Prosedur yang terstandarisasi dan tervalidasi untuk penyiapan titik *phlebotomy* hendaklah diikuti dengan menggunakan larutan desinfeksi yang sesuai dan dibiarkan mengering sesuai dengan jenis desinfektan. Tanggal daluwarsa desinfektan hendaklah diperiksa. Bila menggunakan botol isi ulang untuk larutan desinfektan, hendaklah dilakukan pembersihan sebelum diisi ulang. Tanggal pembuatan dan tanggal pembukaan desinfektan yang dibuat sendiri hendaklah tercantum pada label. Area kulit donor yang didesinfeksi hendaklah tidak disentuh dan dijaga kebersihannya setelah dilakukan desinfeksi dan sebelum jarum ditusukkan. Perhatian hendaklah diberikan agar tidak mengusap atau meniup kulit yang telah didesinfeksi.

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PENGAMBILAN DARAH KONVENSIONAL		Halaman 2 dari 5 Nomor : UDDP-PDD-L2- 003 Versi : 001 Tgl. berlaku : 13 Des 2022 Tgl. kaji ulang : 13 Des 2024
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

3.4 CPOB BPOM Butir 7.40

Proses pelabelan sampel hendaklah mencakup langkah (seperti segera memberi label pada tabung di tempat) untuk mencegah kesalahan dalam mengidentifikasi sampel. Sampel uji hendaklah segera diberi label dengan tepat yaitu label yang berkaitan antara donor, sampel dan komponen darah dengan tetap menjaga kerahasiaan donor.

3.5 CPOB BPOM Butir 7.41

Segera setelah proses pengambilan darah dimulai, hendaklah dilakukan pencampuran darah dengan antikoagulan untuk menghindarkan risiko aktivasi kaskade koagulasi darah. Setelah itu, kantong darah hendaklah digoyang dengan perlahan secara berkala. Penggoyangan dapat dilakukan dengan alat otomatis atau manual yang dilakukan setidaknya setiap 90 detik.

3.6 CPOB BPOM Butir 7.42

Pengambilan satu kantong darah lengkap hendaklah dicapai dalam 12- 15 menit (bergantung pada komponen yang akan dipersiapkan nanti), karena jangka waktu yang lebih lama dapat menyebabkan aktivasi faktor koagulasi dan komponen selular.

3.7 CPOB BPOM Butir 7.43

Catatan hendaklah disimpan untuk tiap aktivitas yang terkait dengan donasi darah, termasuk identifikasi personil yang melakukan pengambilan darah. Catatan hendaklah juga dapat menunjukkan setiap proses donasi yang gagal, reaksi atau kejadian yang tidak diinginkan.

3.8 CPOB BPOM Butir 7.44

Keberterimaan waktu maksimum pengambilan darah untuk pengolahan komponen hendaklah ditetapkan dan dikendalikan. Donasi yang melewati batas waktu maksimum hendaklah dicatat dan dibuang.

3.9 CPOB BPOM Butir 7.45- 7.46

Selang kantong darah hendaklah ditutup pada ujungnya sedekat mungkin dengan kantong darah, kemudian dipisahkan dari kantong darah. Sistem penomoran yang unik hendaklah digunakan untuk mengidentifikasi tiap donor dan keterkaitan dengan donasi darah, komponen darah terkait, sampel dan catatan, untuk menautkan masing-masing dengan yang lain.

3.10 CPOB BPOM Butir 7.47

Ketika donasi selesai dilakukan, semua catatan, kantong darah dan sampel laboratorium hendaklah diperiksa kesesuaiannya dengan nomor donasi yang diterbitkan.

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PENGAMBILAN DARAH KONVENSIONAL		Halaman 3 dari 5 Nomor : UDDP-PDD-L2- 003 Versi : 001 Tgl. berlaku : 13 Des 2022 Tgl. kaji ulang : 13 Des 2024
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

3.11 CPOB BPOM Butir 7.48

Label nomor donasi yang tidak digunakan hendaklah dibuang menggunakan prosedur yang terkendali. Setelah pengambilan darah, kantong darah hendaklah ditangani dengan cara yang tepat untuk menjaga mutu darah.

3.12 Permenkes No.91 Tahun 2015

Pengambilan Darah Lengkap, Dokumentasi Donor yaitu Dokumen untuk setiap kegiatan harus dipelihara termasuk untuk penyumbangan darah yang gagal, reaksi samping atau kejadian yang tidak diharapkan. Dokumen harus mencakup rincian data pendonor dengan lengkap, pemeriksaan medis, tipe dan jumlah komponen darah yang diambil, lokasi serta tanggal penyumbangan darah. Dokumen harus menuangkan informasi yang dapat dilacak dengan lengkap dari sejak penyumbangan darah hingga detil bahan dan peralatan yang digunakan dan identifikasi petugas yang menjalankan setiap kegiatan. Dokumen harus terpelihara dalam kondisi yang baik dan bertahan untuk periode waktu yang ditetapkan oleh UTD atau oleh ketentuan yang telah disetujui untuk diberlakukan.

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2015
- 4.2 Pedoman CPOB di UTD dan Pusat Plasmaferesis BPOM tahun 2017
- 4.3 POPP CPOB di UTD dan Pusat Plasmaferesis BPOM tahun 2018

5. Definisi dan Singkatan

5.1 Definisi

Pengambilan Darah Donor : Kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan darah dengan proses meliputi pencucian lengan donor, desinfeksi lengan donor, pengambilan darah dan sampel darah penanganan pasca penyumbangan darah serta pencatatan dan pelaporan

5.2 Singkatan

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| 5.2.1 APD | : Alat Pelindung Diri |
| 5.2.2 BPOM | : Badan Pengawasan Obat dan Makanan |
| 5.2.3 CPOB | : Cara Pembuatan Obat yang Baik |
| 5.2.4 PMK | : Peraturan Menteri Kesehatan |
| 5.2.5 SOP | : Standar Prosedur Operasional |
| 5.2.6 TPD | : Teknisi Pelayanan Darah |
| 5.2.7 UDDP | : Unit Donor Darah |
| 5.2.8 UTD | : Unit Transfusi Darah |

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PENGAMBILAN DARAH KONVENSIONAL		Halaman 4 dari 5 Nomor : UDDP-PDD-L2- 003 Versi : 001
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	Tgl. berlaku : 13 Des 2022 Tgl. kaji ulang : 13 Des 2024

6. Peran dan Tanggung jawab

Peran	Tanggung jawab
Manajer kualitas	• Melakukan Kontrol Dokumen Pengambilan Darah
Kepala Bidang Pelayanan Darah	• Memberikan persetujuan pada keseluruhan kegiatan yang berlangsung di sub bidang penyediaan darah • Mengesahkan dokumen SPO
Kepala sub bidang/ seksi Penyediaan Darah	• Mengatur kecukupan petugas, peralatan dan bahan habis pakai sesuai kebutuhan • Inspeksi secara periodik proses pengambilan darah donor • Menjamin pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan proses pengambilan darah donor • Inspeksi secara periodik pencatatan dan pelaporan proses pengambilan darah donor • Melakukan evaluasi hasil pengambilan darah donor
Petugas Teknis Pengambilan Darah (TPD dan Perawat)	• Melakukan persiapan peralatan dan bahan habis pakai sesuai kebutuhan • Melakukan proses pengambilan darah donor sesuai SPO • Melakukan pencatatan dan pelaporan

7. Prosedur

- 7.1 Gunakan alat pelindung diri (APD) saat melakukan persiapan peralatan dan bahan habis pakai.
- 7.2 Siapkan peralatan dan bahan habis pakai sesuai Instruksi Kerja Pengambilan Darah Konvensional (UDDP-PDD-L3-007).
- 7.3 Lakukan pengecekan peralatan sebagai validasi sebelum digunakan.
- 7.4 Lakukan dekontaminasi meja kerja menggunakan alkohol 70 % sebelum dan sesudah melakukan pengambilan darah donor.
- 7.5 Pastikan bahwa fasilitas cuci tangan donor telah tersedia.
- 7.6 Pastikan bahwa donor telah melakukan cuci tangan sesuai Instruksi Kerja Cuci Tangan Donor (UDDP-PDD-L3-005).
- 7.7 Siapkan ruangan dan kursi donor pengambilan darah.
- 7.8 Siapkan alat dan bahan habis pakai desinfeksi.
- 7.9 Lakukan proses desinfeksi sesuai Instruksi Kerja Pengambilan Darah Konvensional (UDDP-PDD-L3-007).
- 7.10 Siapkan alat dan bahan habis pakai pengambilan darah.
- 7.11 Periksa kesesuaian identitas donor dengan formulir kuesioner dan *informed consent* donor.
- 7.12 Lakukan validasi kantong.
- 7.13 Lakukan persiapan pengambilan darah donor.

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PENGAMBILAN DARAH KONVENSIONAL		Halaman 5 dari 5 Nomor : UDDP-PDD-L2- 003 Versi : 001 Tgl. berlaku : 13 Des 2022 Tgl. kaji ulang : 13 Des 2024
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

- 7.14 Lakukan proses pengambilan darah dan sampel darah serta perawatan luka sesuai Instruksi Kerja Pengambilan Darah Konvensional (UDDP-PDD-L3-007).
- 7.15 Pastikan telah terjadi kegagalan pengambilan darah.
- 7.16 Hentikan proses pengambilan darah.
- 7.17 Rawat luka pengambilan darah.
- 7.18 Tanyakan kesediaan donor untuk pengambilan darah di lengan yang lain dengan kondisi tertentu.
- 7.19 Lakukan pengambilan darah dengan kantong baru sesuai Instruksi Kerja Pengambilan Darah Donor yang Gagal (UDDP-PDD-L3-014) jika donor bersedia.
- 7.20 Amati tanda - tanda reaksi pengambilan darah.
- 7.21 Lakukan penanganan reaksi pengambilan darah sesuai dengan Instruksi Kerja Penanganan Reaksi Donor Akibat Pengambilan Darah Donor (UDDP-PDD-L3-013).
- 7.22 Laporkan reaksi pengambilan darah kepada dokter yang bertanggung jawab.
- 7.23 Pastikan semua proses pengambilan darah telah tercatat.
- 7.24 Pastikan semua data proses pengambilan darah telah tercatat dalam sistem informasi manajemen.

8. Dokumen Terkait

- 8.1 Instruksi Kerja No.UDDP-PDD-L3-005 Cuci Lengan Donor
- 8.2 Instruksi Kerja No.UDDP-PDD-L3-007 Pengambilan Darah Konvensional
- 8.3 Instruksi Kerja No.UDDP-PDD-L3-013 Penanganan Reaksi Donor Akibat Pengambilan Darah Donor
- 8.4 Instruksi Kerja No.UDDP-PDD-L3-014 Pengambilan Darah Donor yang Gagal

9. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Riwayat Perubahan
001	02/11/2022	PMK dan CPOB	Dokumen Baru

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

MASTER